

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA BREVE DE FOBIA SOCIAL (BSPS)

Brief Social Phobia Scale (Davidson et al., 1991, 1997) · Adaptación Española (Bobes et al., 1999, 2004)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala Breve de Fobia Social (Brief Social Phobia Scale, BSPS)
Sigla / Acrónimo	BSPS
Autoría original	Jonathan R. T. Davidson, C. M. Miner, J. DeVeugh-Geiss et al. (Duke University Medical Center, 1991, 1997)
Adaptación en español	Julio Bobes García, M. P. García-Portilla, M. T. Bascarán et al. (1999, 2004, Ars Medica / CIBERSAM)
Constructo evaluado	Severidad clínica del trastorno de ansiedad social en sus dimensiones de temor, evitación y síntomas autonómicos
Población diana	Adolescentes y adultos con timidez invalidante, fobia social generalizada o ansiedad de rendimiento
Tiempo de aplicación	8 a 12 minutos (heteroadministrado mediante entrevista clínica semiestructurada)
Estructura y formato	18 ítems calificados de 0 (ninguno) a 4 (extremo) divididos en tres subescalas independientes
Condiciones de uso	Dominio público para práctica asistencial e investigación clínica no comercial citando a los autores

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social) se caracteriza por un miedo intenso, persistente y desproporcionado a situaciones sociales o de actuación en público donde el individuo puede ser examinado, juzgado negativamente o humillado por los demás. Siguiendo el **Modelo Cognitivo de Clark y Wells**, cuando la persona fóbica social entra en una situación temida, experimenta un cambio en la focalización atencional hacia el procesamiento de sí mismo como objeto social defectuoso, activando síntomas neurovegetativos visibles que interpreta catastróficamente.

Jonathan Davidson y su equipo diseñaron la BSPS como una entrevista clínica clinimétrica para ensayos farmacológicos y psicoterapéuticos. A diferencia de escalas que solo miden el miedo subjetivo, la BSPS introduce una subescala pionera de síntomas autonómicos objetivos (rubor facial, palpitaciones, temblores y sudoración profusa), permitiendo evaluar la diana fisiológica directa de los betabloqueantes y antidepresivos serotoninérgicos.

3. ESTRUCTURA DE SUBESCALAS Y SITUACIONES EVALUADAS

Subescala	Ítems Origen	Rango	Contenido y Operacionalización Clínica
1. Temor / Miedo	Ítems 1 a 7	0 - 28	Grado de miedo subjetivo ante 7 situaciones: hablar ante público, hablar en reuniones, hablar con figuras de autoridad, asistir a fiestas/actos sociales, ser observado mientras trabaja, comer/beber en público y escribir en público
2. Evitación	Ítems 8 a 14	0 - 28	Frecuencia de conductas de evitación o escape ante exactamente las mismas 7 situaciones sociales evaluadas en la subescala de temor
3. Síntomas Fisiológicos	Ítems 15 a 18	0 - 16	Intensidad de la hiperactivación autonómica simpática: rubor facial (15), palpitaciones (16), temblor de manos/voz (17) y sudoración profusa (18)

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente consistencia global; alfa de Cronbach $\alpha = 0.91 - 0.94$; subescalas: Temor $\alpha = 0.86$, Evitación $\alpha = 0.85$, Fisiológica $\alpha = 0.76$ (Bobes et al., 1999; Davidson et al., 1997).
Fiabilidad interobservador	Concordancia excelente entre evaluadores psiquiátricos independientes; coeficiente de correlación intra-clase CCI = $0.88 - 0.93$.
Validez concurrente	Correlación positiva muy alta con la Escala de Ansiedad Social de Liebowitz (LSAS, $r = 0.87$), Social Phobia Inventory (SPIN, $r = 0.82$) y CGI-S de gravedad ($r = 0.74$).
Estructura factorial	Los análisis factoriales confirmatorios ratifican el modelo trifactorial propuesto por Davidson, correspondiente a las tres subescalas clínicas.
Sensibilidad al cambio	Excelente reactividad en ensayos clínicos con ISRS (paroxetina, sertralina); una reducción de $\geq 30\%$ o ≥ 12 puntos define respuesta clínica favorable.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Entrevista clínica guiada	El clínico formula preguntas estructuradas para explorar la última semana (o el último mes en evaluaciones iniciales).
Calificación de ítems	Cada ítem se califica de 0 a 4: 0 = Ninguno / Nunca ; 1 = Leve / Rara vez ; 2 = Moderado / A veces ; 3 = Severo / Frecuentemente ; 4 = Extremo / Siempre .
Puntuación directa total	Suma aritmética simple de los 18 ítems. Rango teórico posible: 0 a 72 puntos . No contiene ítems invertidos.
Cálculo de subescalas	Subescala Temor = suma ítems 1 a 7 (0-28); Subescala Evitación = suma ítems 8 a 14 (0-28); Subescala Fisiológica = suma ítems 15 a 18 (0-16).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación BSPS	Percentil Aprox.	Nivel de Fobia Social	Significación y Repercusión Funcional
0 - 19 puntos	< Pc 60	Ansiedad Social Leve / Subclínica	Timidez ordinaria o malestar leve sin interferencia ocupacional relevante.
20 - 34 puntos	Pc 65 - Pc 79	Fobia Social Moderada	Afectación manifiesta en vida social y laboral; fobia social circunscrita.
35 - 49 puntos	Pc 80 - Pc 94	Fobia Social Severa	Aislamiento social significativo; fobia social generalizada floridada.
50 - 72 puntos	$\geq$ Pc 95	Fobia Social Muy Severa / Extrema	Invalidez social casi total; confinamiento domiciliario o solapamiento con TPET.

PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS CRÍTICOS:

- **BSPS ≥ 20 puntos:** Punto de corte canónico para confirmar el diagnóstico de Fobia Social clínicamente relevante (sensibilidad 88%, especificidad 85%).
- **Criterio de Remisión Postratamiento:** Puntuación final < 15 puntos o reducción de al menos el 50% de la puntuación basal tras tratamiento farmacológico o cognitivo-conductual.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE TRATAMIENTO BASADO EN EL PERFIL BSPS

Paso 1: Aplicación de la entrevista BSPS: Calcular puntuación total (0-72) y de las 3 subescalas.

Paso 2: Si el Problema es Puramente de Ansiedad de Rendimiento (Fobia Circunscrita, ítems 1 y 16 altos aislados):

- Prescripción de betabloqueante periférico a demanda (propranolol 10-20 mg) 1 hora antes de exposiciones puntuales (conferencias, exámenes orales).

Paso 3: Si BSPS $\geq$ 20 con Fobia Social Generalizada (múltiples ítems de Temor y Evitación alterados):

- Tratamiento de primera línea: TCC individual o grupal focalizada en fobia social (exposición con prevención de conductas de seguridad, entrenamiento atencional externo y reestructuración cognitiva).
- Farmacoterapia de mantenimiento continuada con ISRS (sertralina, escitalopram, paroxetina) o venlafaxina a dosis terapéuticas plenas durante al menos 12 meses.

Paso 4: Monitorización mensual: Evaluar descenso en la subescala de Evitación (la disminución de evitación es el mejor predictor de mantenimiento a largo plazo).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN SALUD MENTAL

Identificación: Paciente varón de 27 años, ingeniero de software, que consulta impulsado por su empresa tras rechazar un ascenso laboral que le obligaría a liderar reuniones con clientes. Consumo semanal de 4-5 copas de alcohol antes de acudir a eventos sociales.

Evaluación BSPS Inicial: Puntuación Total = **44 / 72** (Fobia Social Severa).

- Desglose por subescalas: Temor = 18/28 (máximo en hablar en reuniones, con autoridades y ser observado); Evitación = 16/28 (evita reuniones de equipo y comidas de trabajo); Síntomas Fisiológicos = 10/16 (rubor facial intenso = 3, palpitaciones = 3, sudoración = 3).

Diagnóstico: Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social) de tipo Generalizado, con conductas desadaptativas de automedicación alcohólica.

Plan Terapéutico: Cese inmediato del consumo de alcohol como conducta de seguridad; inicio de sertralina 100 mg/día combinada con protocolo de TCC de Clark y Wells (grabaciones en vídeo para corregir la autoimagen distorsionada y experimentos conductuales de exposición sin conductas de seguridad).

Reevaluación a los 5 meses: BSPS Total descendió a **14 / 72** (Remisión clínica, reducción de 30 puntos); el paciente aceptó la promoción laboral y lidera reuniones sin rubor limitante.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo de Dependencia:

- **Abuso de Alcohol / Benzodiacepinas:** Alta prevalencia de alcoholismo secundario utilizado como "lubricante social"; cribar con AUDIT.
- **Depresión Secundaria Severa:** El aislamiento social crónico engendra sentimientos de fracaso vital y desesperanza autolítica.

Diagnóstico Diferencial:

- **Fobia Social vs. Agorafobia:** En la fobia social el temor central es el escrutinio negativo y el bochorno; en la agorafobia es no poder escapar o recibir ayuda en caso de pánico.
- **Trastorno de la Personalidad por Evitación (TPE):** Patrón más arraigado de hipersensibilidad al rechazo que impregna toda la identidad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Davidson, J. R., Miner, C. M., DeVaugh-Geiss, J., Tupler, L. A., Colket, J. T., & Potts, N. L. (1997). The Brief Social Phobia Scale: a psychometric evaluation. *Psychological Medicine*, 27(1), 161-166. <https://doi.org/10.1017/s0033291796004163>
- Bobes, J., Badía, X., Luque, A., García, M., González, M. P., Dal-Ré, R., & Grupo de Validación en España de la BSPS. (1999). Validación de las versiones en español de los cuestionarios Liebowitz Social Anxiety Scale, Social Phobia and Anxiety Inventory y Brief Social Phobia Scale. *Medicina Clínica*, 112(14), 530-538.
- Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R. G. Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A. Hope, & F. R. Schneier (Eds.), *Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment* (pp. 69-93). Guilford Press.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.